Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Valentina Javiera Rías Vargas			Sexo	F	X	M
Fecha Nacimiento	19/02/2019	Edad actual	6 años	1 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	Psje. Tarso norte 127 Capilla de los Viñedos 2			Teléfono			
Lengua materna	Español	Grado dominio	Calle Larga	comprende ☐ habla ☐ lee ☐ escribe ☐			
Lengua de uso	Español	Grado dominio		comprende ☐ habla ☐ lee ☐ escribe ☐			
Escolaridad actual:	1° Básico	Establecimiento		Liceo Mixto Básica 2.			

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 19/03/2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Paulina Vargas S.	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 19/03/2025	2. Fecha de la entrevista: 17.03.2026.
Nombre: Tamara Fuentes Toro.	Nombre: DANIELA CADEMAN C.
Rol/cargo: Educ. Diferencial	Rol/cargo: PSICOPEDAGOGA.
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Domicilio Actual: Calle Ortiz N°25 San Felipe.
Trastorno del Espectro Autista.
- Actualización de datos.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☐ Sí (especificar)

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología: ✓	Terapia Ocupacional: ✓
Neurología: ✓	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Escaneado con CamScanner

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida 38-39 semanas

Tipo de parto: [X] normal [ ] inducido [ ] fórceps [ ] cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? [X] SI [ ] NO | Peso: 3.330 | Talla: 48 cms

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

Sin observaciones

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Si	No X	Traumatismos	Si	No X	Encefalitis	Si	No X
Obesidad	Si	No X	Intoxicación	Si	No X	Meningitis	Si	No X
Fiebre alta	Si X	No	Enfermedad respiratoria	Si X	No	Otra(s)		
Convulsiones	Si	No X	Asma	Si	No X			
Hospitalizaciones	Si X	No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	Si X	No		Vacunas	Si X	No

Observaciones:

Hospitalizada 3 semanas (3 meses) Virus Sincicial.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 3 meses	Se sienta sólo/a: 6 meses	Camina sin apoyo: 1a, 8
Primeras palabras: 3 años	Primeras frases: 4a	Se viste solo/a: 3a
Controla esfinter vesical Diurno: _____ Nocturno:_____	Controla esfinter anal Diurno: _____ Nocturno:_____	

Observaciones:

Usa pañales en la noche

En su actividad motora general se aprecia: [X] normal [ ] activo [ ] hiperactivo [ ] hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia: [X] normal [ ] hipertónico [ ] hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	Si X	No	Caídas frecuentes	Si	No X	Dominancia lateral	Si X	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	Si X	No	Prensión	Si X	No	Pinza	Si X	No
Ensarta	Si X	No	Dibuja	Si X	No	Escribe	Si X	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	Si X	No	Manipula y Explora objetos	Si X	No
Demanda objetos y compañía	Si X	No	Comprende prohibiciones	Si X	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	Si X	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	No X

Observaciones:

Usa objeto de apego (oso peluche)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Escaneado con CamScanner

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí X	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí X	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No X	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí X	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No X	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí X	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No X	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No X
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí X	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No X
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No X	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No X
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No X	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No X
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No X	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No X

Observaciones:

Sin observaciones

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☒ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí X	No	Emite/produce frases	Sí X	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí X	No	Relata experiencias	Sí	No X
Emite palabras/produce señas	Sí X	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No X

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	Sí X	No	Sigue instrucciones simples	Sí X	No
Identifica personas	Sí X	No	Sigue instrucciones complejas	Sí X	No
Comprende conceptos abstractos	Sí X	No	Sigue instrucciones grupales	Sí X	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí X	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí a veces	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):

Observaciones: Se instiga el diálogo.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí a veces	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí a veces	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No X	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí X	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No X	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí X	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es: En la casa.

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☐ natural ☐ desmesurada	☐ natural ☐ desmesurada	☐ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

Selectiva, con los adultos. Se pone nerviosa, aletea y transpira.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Escaneado con CamScanner

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante					
Vacunas al día	Sí X	No	Trastorno motor	Sí	No X
Epilepsia	Sí	No X	Problema bronco-respiratorio	Sí	No X
Problemas cardiacos	Sí	No X	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No X
Paraplejia	Sí	No X	Trastorno emocional	Sí	No X
Pérdida auditiva	Sí	No X	Trastorno conductual	Sí	No X
Pérdida visual	Sí	No X	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☒ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☐ normal ☐ bajo peso ☒ obesidad

Sueño: ☐ normal ☐ tranquilo ☒ inquieto Horas que duerme: 5 horas

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☒ solo ☐ acompañado
(Especifique):

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☒ alegre ☒ juguetón/bromista ☒ risueño(a) ☐ triste ☒ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:
Presenta trastornos del sueño desde los 2 años. En tratamiento. Risperdona (6 gotas) Vigisom (½ tabletas)

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Rodrigo Ríos	Papá	42	4°-Medio	Operador maquinaria
2. Paula Vargas	Mamá	38	Tec.	Tec. Enfermería
3. María José Ríos	Hermana	11	5° Básico	Estudiante
4. Antonia Ríos	Hermana	14	1°-Medio	Estudiante
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Papá, mamá y hermanas con rasgos autistas.

Observaciones:

Sin observaciones

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Escaneado con CamScanner

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	3 Años		Asistió a jardín infantil	Sí	No
N° de colegios en que ha estudiado	2		Modalidad de enseñanza Regular ☐ Especial ☒ Técnica ☐:		

Motivo de los cambios:
Asistió 3 años a escuela especial de lenguaje.

Ha repetido curso/s	Sí	No	Curso(s)	Motivo:
		X		

Situación actual

Nivel/curso actual	1° "A"		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No	**Dificultad para participar**	Sí	No	**Conducta disruptiva**	Sí	No
Asiste regularmente	Sí	No	Asiste con agrado	Sí	No	Apoyo familiar en tareas	Sí	No	Amigos (as)	Sí	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☒ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☐ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☒ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☒ madre ☐ padre ☒ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☒ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☒ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

5

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Escaneado con CamScanner